

Información Paciente

Nombre : Jose Francisco Espinoza Vergara
Edad : 62a 1m 26d
Dirección : Quellon 4158 Villa Chiloe

Rut : 9.431.653-7
Fecha Nacto: 06/06/1962
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A211310
Sexo : Masculino
Teléfono : 937797135

N° Epicrisis
408468

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalizacion

Fecha Ingreso : 30/07/2024 09:56

Días Estadía : 2

Unidad de Egreso : Emergencia Adulto

Fecha Egreso : 01/08/2024 15:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

MC: sin débito por ostomía + vómitos

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiologia

Resumen Clínico

Nombre José Francisco Espinoza Vergara
Edad 61 años
RUT 9431653-7
Ingreso HSR 30/07

ANTECEDENTES

- AM: cáncer de colon sigmoides en CCPP, epilepsia secundaria a QMT
- Qx: RAB con resección en bloc de vejiga, uréteres distales, próstata, segmento de íleon, apéndice y pared abdominal. Entero entero anastomosis II isoperistáltica manual. Bricker. Colostomía terminal.
- Alergias: no
- Medicamentos: no refiere

HISTORIA

Paciente con antecedentes descritos hospitalizado recientemente por cuadro de aprox 1 semana de aumento volumen zona perianal, con salida de secreción purulenta desde el día del ingreso. Niega fiebre, náuseas o vómitos. Al examen físico hacia hora 2-3 se observa lesión aprox 3 mm en relación a aumento de volumen fluctuante, con salida de secreción purulenta. Ingresó a pabellón donde se realiza drenaje de absceso perianal con instalación de 2 penrose en plan de retiro en 1 semana. Ingresó 3 días después del alta por presentar episodio de deposiciones por herida operatoria con mínima salida de deposiciones por bolsa de ostomía.

HISTORIA ONCOLÓGICA

Cáncer de colon sigmoides debut localmente avanzado Marzo 2022. Exanteración pélvica Junio 2022 QT FOLFOX suspendida por RAM - convulsión. Progresión local y carcinomatosis. Mayo 2024 hospitalizado por gangrena de Fournier. Ingresó por extensa colección en el plano cutáneo del periné y el escroto, con burbujas de gas en su interior obs gangrena de Fournier. Urología realiza aseo quirúrgico el 30/04/2024. Se describe hallazgo fosa isquioanal derecha con bolsillo con gran colección hacia espacio isquiocavernoso derecho con masa de aspecto tumoral, la cual se reseca parcialmente y envío de cultivo + biopsia diferida. Cultivo absceso gangrena Fournier (+) E.coli + Estafilococo lugdunensis multisensible.

EXÁMENES

29/07 Lab: Ac lactico 14.5 crea 1.46 BUN 18.8 gluc 107 PCR 7.9 ELP 136/3.33/108 pH 7.42 PCO2 36.3 HCO3 23.2 Hb 12.5

Fecha Epicrisis : 01/08/2024 15:50

Fecha Última Actualización: 01-08-2024 15:50:56

Página 2 de 3

Hcto 39.5 GB 9350 PLQ 223000 INR 1.09 TTPA 28.8

TAC AP 30/07 Masa necrótica infiltrativa pelviana conocida con discreto menor tamaño de los cambios inflamatorios -
Infeccioso con burbujas de gas en su espesor de la fosa isquio anal y región inguinal izquierda.

Menor tamaño foco condensación en LII. Resto sin cambios

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

- 1.- Colección pelviana - tumor infiltrativo
 - Drenaje absceso 25/07
 - Fístula entero cutánea
- 2.- Cáncer de colon sigmoides en CCPP
 - Exanteración pélvica. Colostomía terminal. Bricker.
 - Epilepsia secundaria a QMT
- 3.- Neumonía obs aspirativa en resolución

PLAN

- ATB
- Manejo del dolor
- CCPP

EVOLUCION HOSPITALIZACION

Paciente evoluciona con adecuado manejo del dolor con analgesia, buena tolerancia a alimentación y débito por colostomía y fístula entero-cutánea. Evaluado por equipo de coloproctología, sin indicación quirúrgica, mantener manejo paliativo. Se indica esquema antibiótico con Ceftriaxona-Metronidazol EV pero en contexto de parámetros inflamatorios bajos y ausencia de fiebre equipo de infectología sugiere suspender y cambiar a Amoxi/Clav por 5 días más. Evaluado por equipo de CCPP que ajusta medicamentos y sugiere mantener controles en ambulatorio.

En condiciones de alta con control ambulatorio con CCPP y coloproctología

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

- 1.- Colección pelviana - tumor infiltrativo
 - Drenaje absceso 25/07
 - Fístula entero cutánea sin indicación qx
- 2.- Cáncer de colon sigmoides en CCPP
 - Exanteración pélvica. Colostomía terminal. Bricker.
 - Epilepsia secundaria a QMT
- 3.- Neumonía obs aspirativa en resolución

Diagnóstico de Egreso

TUMOR MALIGNO DEL COLON SIGMOIDE -

Condición de Egreso

Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en BCG, HDN estable, afebril.

Adecuado manejo del dolor con analgesia.

Diuresis por ostomía Bricker.

Deposiciones por colostomía y fístula entero-cutánea sin elementos patológicos.

Buena tolerancia a alimentación.

Plan Post Alta

Reposo relativo

Régimen liviano

Paracetamol 1 g cada 8 hrs por 7 días vía oral

Metamizol 300 mg cada 8 hrs por 7 días vía oral

Domperidona 10 mg cada 8 hrs vía oral si náuseas

Pregabalina 75 mg en la noche vía oral

Amoxicilina/Acido Clavulanico 875/125 mg cada 12 hrs por 5 días vía oral

Omeprazol 20 mg al día por 5 días vía oral

Miconazol 2% aplicar en cavidad oral 4 veces al día, enjuagar o tragar x 7 días.

Fecha Epicrisis : 01/08/2024 15:50

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 01-08-2024 15:50:56

Página 3 de 3

Levetiracetam 1500 mg en la noche vía oral

Morfina 6 gotas cada 4 hrs vía oral + 6 gotas SOS

Suspender parches de Buprenorfina

Mantener zona perianal limpia y seca. Lavar con agua y secar con secador de pelo. Evitar colocar cremas u otras sustancias sobre la herida.

Mantener controles con Cuidados Paliativos. Paciente conocido por equipo por lo que se le contactará para agendar hora.

Curaciones en CESFAM. Se entrega certificado.

Control en DIPRECC en 2-3 semanas en poli becados. Se le contactará para agendar hora.

Acudir a urgencias en caso de dolor intenso que no cede con analgesia indicada, fiebre por más de 3 días, intolerancia a la alimentación, sangrado abundante o cuando estime necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles



Bec. Paz Guesalaga Ruiz-Tagle

Becado/Residente

INTERNO

Médico Tratante (Staff)